

보건복지부 고시 제2024-100호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 (보건복지부 고시 제2024-72호(2024. 4. 29.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2024년 5월 30일
보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

II. 약제 "[235] Pyridoxine Hydrochloride + Doxylamine Succinate 복합경구제 (품명 : 디클렉틴장용정 등)"를 별지 1과 같이 신설하고, "[일반원칙] 당뇨병용제, [339] Eltrombopag olamine 경구제(품명: 레볼레이드정 25밀리그램 등), [339] Romiplostim 주사제(품명: 로미플레이트주 250마이크로그램), [421] GnRH agonist 주사제"의 세부인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2024년 6월 1일부터 시행한다. 다만, "[421] GnRH agonist 주사제"의 개정 내용은 2025년 1월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 1]

[235] 최토제, 진토제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[235] Pyridoxine Hydrochloride + Doxylamine Succinate 복합경구제(품명 : 디클렉틴장용정 등)	<신 설>	각 약제별 허가사항 범위 내(보존적 요법에 반응하지 않는 임부의 구역 및 구토 조절)에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 임신 16주(16주+6일) 이내 나. 임신 16주 이후 구역, 구토증상으로 일상생활에 지장이 있으면서 다른 질환에 의한 발생이 배제된 경우	○ Pyridoxine Hydrochloride + Doxylamine Succinate 복합경구제(품명 : 디클렉틴장용정 등)가 신규 등재 예정임에 따라, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함.
※ 관련근거 · Williams Obstetrics, 26e (2022.) · Current Medical Diagnosis & Treatment, 62e (2023.) · Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14E (2022.) · Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e (2022.)			

- Antenatal care (NICE guideline, 2021.8.)
- Nausea and Vomiting of Pregnancy (ACOG Practice Bulletin, 2018.1.)
- The Management of Nausea and Vomiting of Pregnancy and Hyperemesis Gravidarum (Royal College of Obstetricians & Gynaecologists, 2016.6.)
- Koren G at el. Effectiveness of delayed-release doxylamine and pyridoxine for nausea and vomiting of pregnancy: a randomized placebo controlled trial Am J Obstet Gynecol 2010;203:571.e1-7.
- Persaud N at el. Doxylamine-pyridoxine for nausea and vomiting of pregnancy randomized placebo controlled trial: Prespecified analyses and reanalysis. PLoS ONE. 2018 Jan, 13(1):e0189978.
- 대한산부인과학회(대한산부인과학회 제26-017-2023호, 2023.11.20.)
- 한국모자보건학회(한국모자보건학회 제2023-001호, 2023.11.15.)

[별지 2]

[일반원칙] 당뇨병용제				
구 분	세부인정기준 및 방법			
	현 행		개 정(안)	
[일반원칙] 당뇨병용제	(생 략)		(현행과 같음)	
	※ 대상약제 [경구제 중 단일제]		※ 대상약제 [경구제 중 단일제]	
	성분군	성분명	성분군	성분명
	Biguanide계	Metformin HCl	Biguanide계	Metformin HCl
	Sulfonylurea계	Glibenclamide, Gliclazide, Glimepiride, Glipizide	Sulfonylurea계	Glibenclamide, Gliclazide, Glimepiride, Glipizide
	Meglitinide계	Mitiglinide calcium hydrate, Nateglinide, Repaglinide	Meglitinide계	Mitiglinide calcium hydrate, Nateglinide, Repaglinide
	α-glucosidase inhibitor계	Acarbose, Miglitol, Voglibose	α-glucosidase inhibitor계	Acarbose, Miglitol, Voglibose
	Thiazolidinedione계	Lobeglitazone sulfate, Pioglitazone HCl	Thiazolidinedione계	Lobeglitazone sulfate, Pioglitazone HCl
	DPP-IV inhibitor계	Alogliptin, Anagliptin, Evogliptin, Gemigliptin, Linagliptin, <추 가>, Saxagliptin, Sitagliptin	DPP-IV inhibitor계	Alogliptin, Anagliptin, Evogliptin, Gemigliptin, Linagliptin, Linagliptin besylate , Saxagliptin,

[일반원칙] 당뇨병용제															
구 분	세부인정기준 및 방법			사유											
	현 행		개 정(안)												
	<table><tr><th>성분군</th><th>성분명</th></tr><tr><td></td><td>phosphate, Sitagliptin HCl, Teneligliptin HBr, Teneligliptin HCl, Teneligliptin ditosylate, Vildagliptin, Vildagliptin HCl, Vildagliptin nitrate</td></tr><tr><td>SGLT-2 inhibitor계</td><td>Dapagliflozin, Empagliflozin, Ertugliflozin, Ipragliflozin, Enavogliflozin</td></tr></table>	성분군	성분명		phosphate, Sitagliptin HCl, Teneligliptin HBr, Teneligliptin HCl, Teneligliptin ditosylate, Vildagliptin, Vildagliptin HCl, Vildagliptin nitrate	SGLT-2 inhibitor계	Dapagliflozin, Empagliflozin, Ertugliflozin, Ipragliflozin, Enavogliflozin	<table><tr><th>성분군</th><th>성분명</th></tr><tr><td></td><td>Sitagliptin phosphate, Sitagliptin HCl, Teneligliptin HBr, Teneligliptin HCl, Teneligliptin ditosylate, Vildagliptin, Vildagliptin HCl, Vildagliptin nitrate</td></tr><tr><td>SGLT-2 inhibitor계</td><td>Dapagliflozin, Empagliflozin, Ertugliflozin, Ipragliflozin, Enavogliflozin</td></tr></table>	성분군	성분명		Sitagliptin phosphate, Sitagliptin HCl, Teneligliptin HBr, Teneligliptin HCl, Teneligliptin ditosylate, Vildagliptin, Vildagliptin HCl, Vildagliptin nitrate	SGLT-2 inhibitor계	Dapagliflozin, Empagliflozin, Ertugliflozin, Ipragliflozin, Enavogliflozin	
	성분군	성분명													
		phosphate, Sitagliptin HCl, Teneligliptin HBr, Teneligliptin HCl, Teneligliptin ditosylate, Vildagliptin, Vildagliptin HCl, Vildagliptin nitrate													
	SGLT-2 inhibitor계	Dapagliflozin, Empagliflozin, Ertugliflozin, Ipragliflozin, Enavogliflozin													
	성분군	성분명													
	Sitagliptin phosphate, Sitagliptin HCl, Teneligliptin HBr, Teneligliptin HCl, Teneligliptin ditosylate, Vildagliptin, Vildagliptin HCl, Vildagliptin nitrate														
SGLT-2 inhibitor계	Dapagliflozin, Empagliflozin, Ertugliflozin, Ipragliflozin, Enavogliflozin														
[경구제 중 2제 복합제] (생 약)	[경구제 중 2제 복합제] (현행과 같음)														
[경구제 중 3제 복합제] (생 약)	[경구제 중 3제 복합제] (현행과 같음)														
[주사제] (생 약)	[주사제] (현행과 같음)														
※ 관련근거															

[일반원칙] 당뇨병용제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
<요양급여 신규등제에 따른 급여기준 변경 사항>			

[339] 기타의 혈액 및 체액용약			
구 분	현 행	변 경(안)	사유
	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	
[339] Eltrombopag olamine 경구제 (품명: 레볼레이드정 25밀리그램 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준 으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에 투여하는 경우에는 약값 전 액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 성인의 만성 면역성(특발성) 혈소판 감소성 자반증 1) 투여대상 - corticosteroid와 immunoglobulin에 불응인 비장절제 환자 - corticosteroid와 immunoglobulin에 불응인 비장절제술이 의학적 급기인 환자	1. (현행과 같음) - 아 래 - 가. 성인의 만성 면역성(특발성) 혈소판 감소성 자반증 1) 투여대상: <u>corticosteroid와 immunoglobulin에 불응인 환자</u>	○국내·외 허가사 항, 관련 문헌 (교과서, 임상 진료지침, 임상 연구문헌 등) 및 학회 의견 (전문가 의견) 등을 참조하여, 성인의 만성 특 발 성 (면 역 성) 혈소판 감소성 자반증 적응증 에 비장절제 선 행조건 삭제

[339] 기타의 혈액 및 체액용약			
현행		변경(안)	
구분	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	사유
	2) 투여개시 - 혈소판수 $20,000/\mu\text{l}$ 이하 또는 - 혈소판수 $20,000\sim 30,000/\mu\text{l}$ 이더라도 임상적 의의가 있는 출혈(중추신경계 질환, 위장관출혈, 안출혈 등)이 있는 경우 <신 설>	2) (현행과 같음) 3) 투여중단 및 재치료 - 1일 최대 용량으로 4주간 투여 후에도, 투여개시 시점 대비 다음의 반응이 없을 경우 투여를 중단하고, 재치료는 인정하지 아니함. - 다 음 - • 혈소판수 $20,000/\mu\text{l}$ 이하인 경우: 혈소판수가 $20,000/\mu\text{l}$ 초과 • 혈소판수 $20,000\sim 30,000/\mu\text{l}$ 이더라도 임상적 의의가 있는 출혈(중추신경계질환, 위장관출혈, 안출혈 등)이 있는 경우: 임상적 의의가 있는 출혈이 멈추고 투여개시 당시 혈소판수보다 증가	

- 7 -

[339] 기타의 혈액 및 체액용약			
현행		변경(안)	
구분	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	사유
	3) 투여기간: 치료당 최대 6개월까지 인정함. 나. 면역억제요법에 충분한 반응을 보이지 않는 성인의 중증 재생불량성 빈혈 1) (생 략) 2) (생 략) 3) (생 략) 2. 허가사항(효능·효과)을 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여한 경우에도 요양급여를 인정함. - 아 래 - 가. 투여대상: 만 6세 이상 소아의 만성 면역성(특발성) 혈소판 감소성 자반증 환자로 corticosteroid와 immunoglobulin에 불응인 환자 나. 투여개시 - 혈소판수 $20,000/\mu\text{l}$ 이하 또는 - 혈소판수 $20,000\sim 30,000/\mu\text{l}$ 이더라도 임상적 의의가 있는 출혈(중추신경계 질환, 위장관출혈,	4) 투여기간: 치료당 최대 6개월까지 인정함. 나. (현행과 같음) 1) (현행과 같음) 2) (현행과 같음) 3) (현행과 같음) 2. (현행과 같음) 가. (현행과 같음) 나. (현행과 같음)	

- 8 -

[339] 기타의 혈액 및 체액용약			
현행		변경(안)	
구분	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	사유
	<u>안출혈 등</u>)이 있는 경우 <신 설> 다. 투여기간: 치료당 최대 6개월까지 인정함. ※ 허가사항 중 용법·용량 및 사용상의 주의사항(경고, 일반적 주의, 간장애 환자에 대한	다. 투여중단 및 재치료 - 1일 최대 용량으로 4주간 투여 후에도, 투여개시 시점 대비 다음의 반응이 없을 경우 투여를 중단하고, 재치료는 인정하지 아니함. - 다 음 - • 혈소판수 20,000/μl 이하인 경우: 혈소판수가 20,000/μl 초과 • 혈소판수 20,000~30,000/μl 이더라도 임상적 의의가 있는 출혈(중추신경계질환, 위장관출혈, 안출혈 등)이 있는 경우: 임상적 의의가 있는 출혈이 멈추고 투여개시 당시 혈소판수보다 증가 라. 투여기간: 치료당 최대 6개월까지 인정함. ※ (현행과 같음)	

[339] 기타의 혈액 및 체액용약			
현행		변경(안)	
구분	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	사유
	투여 등)을 반드시 준수하여 투여하여야 함.		
[339] Romiplostim 주사제 (품명: 로미플레이트주 250마이크로그램)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에 투여하는 경우에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 성인의 만성 면역성(특발성) 혈소판 감소성 자반증 1) 투여대상 - corticosteroid와 immunoglobulin에 불응인 비장절제 환자 - corticosteroid와 immunoglobulin에 불응인 비장절제술이 의학적 급기인 환자 2) 투여개시 - 혈소판수 20,000/μl 이하 또는 - 혈소판수 20,000~30,000/μl 이더라도 임상적 의의가 있는 출혈(중추신경계 질환, 위장관출혈, 안출혈 등)이 있는 경우	1. (현행과 같음) - 아 래 - 가. 성인의 만성 면역성(특발성) 혈소판 감소성 자반증 1) 투여대상: corticosteroid와 immunoglobulin에 불응인 환자 2) (현행과 같음)	

[339] 기타의 혈액 및 체액용약			사유
현행		변경(안)	
구분	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	
	<신설> 3) 투여기간: 치료당 최대 6개월까지 인정함. 나. 면역억제요법에 불응이거나 면역억제요법이 적용되지 않는 성인의 중증 재생불량성 빈혈 1) (생략) 2) (생략) 3) (생략)	3) 투여중단 및 재치료 - 1일 최대 용량으로 4주간 투여 후에도, 투여개시 시점 대비 다음의 반응이 없을 경우 투여를 중단하고, 재치료는 인정하지 아니함. - 다 음 - • 혈소판수 20,000/μl 이하인 경우: 혈소판수가 20,000/μl 초과 • 혈소판수 20,000~30,000/μl 이더라도 임상적 의의가 있는 출혈(중추신경계 질환, 위장관출혈, 안출혈 등)이 있는 경우: 임상적 의의가 있는 출혈이 멈추고 투여개시 당시 혈소판수보다 증가 4) 투여기간: 치료당 최대 6개월까지 인정함. 나. (현행과 같음) 1) (현행과 같음) 2) (현행과 같음) 3) (현행과 같음)	

- 11 -

[339] 기타의 혈액 및 체액용약			사유
현행		변경(안)	
구분	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	
	2. 허가사항(효능·효과)을 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여한 경우에도 요양급여를 인정함. - 아 래 - 가. 투여대상: 만 1세 이상 소아의 만성 면역성(특발성) 혈소판 감소성 자반증 환자로서 corticosteroid와 immunoglobulin에 불응인 환자 나. 투여개시 - 혈소판수 20,000/μl 이하 또는 - 혈소판수 20,000~30,000/μl 이더라도 임상적 의의가 있는 출혈(중추신경계 질환, 위장관출혈, 안출혈 등)이 있는 경우 <신설>	2. (현행과 같음) 가. (현행과 같음) 나. (현행과 같음) 다. 투여중단 및 재치료 - 1일 최대 용량으로 4주간 투여 후에도, 투여개시 시점 대비 다음의 반응이 없을 경우 투여를 중단하고, 재치료는 인정하지 아니함.	

- 12 -

[339] 기타의 혈액 및 체액용약				
현행		변경(안)		사유
구분	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법		
		- 다 음 - • <u>혈소판수 20,000/μl 이하인 경우:</u> <u>혈소판수가 20,000/μl 초과</u> • <u>혈소판수 20,000~30,000/μl 이더라도 임상적 의의가 있는 출혈(중추신경계 질환, 위장관출혈, 안출혈 등)이 있는 경우:</u> <u>임상적 의의가 있는 출혈이 멈추고 투여 개시 당시 혈소판수보다 증가</u>		
	<u>다.</u> 투여기간: 치료당 최대 6개월까지 인정함. ※ 허가사항 중 용법·용량 및 사용상의 주의사항(경고, 일반적 주의, 간장애 환자에 대한 투여 등)을 반드시 준수하여 투여하여야 함.	<u>라.</u> 투여기간: 치료당 최대 6개월까지 인정함. ※ (현행과 같음)		
※ 관련근거 1) New-generation drugs that stimulate platelet production in chronic immune thrombocytopenic purpura, Lancet 2009; 373: 1562 - 69 2) Novel Thrombopoietic Agents, Drugs 2008; 68 (7): 901-912 3) Thrombopoietin receptor agonists in the treatment of thrombocytopenia, Current Opinion in Hematology 2009, 16:357 - 364 4) American Society of Hematology 2019 guidelines for immune thrombocytopenia (blood advances 10 Dec 2019 · Vol 3, Number 23)				

- 13 -

[339] 기타의 혈액 및 체액용약				
현행		변경(안)		사유
구분	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법		
5) Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia (Blood Research 26 Nov 2019 · Vol 3, Number 22)				
6) Management of immune thrombocytopenia: 2022 update of Korean experts recommendations (Blood Research Vol 57, No. 1 March 2022)				
7) Eltrombopag for management of chronic immune thrombocytopenia (RAISE): a 6-month, randomised, phase 3 study				
8) Decision Making in Perioperative Medicine: Clinical Pearls, Chapter 22: Coagulation Disorders, Immune Thrombocytopenia (ITP)				

[421] 항악성종양제				
현행		변경(안)		사유
구분	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법		
[421] GnRH agonist 주사제	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 대상약제성분 : Goserelin, Leuprolide, Triptorelin 나. 급여범위 : 각 약제 허가사항 범위 내에서 다음과 같이 인정함.	1. (현행과 같음) - 아 래 - 가. (현행과 같음) 나. (현행과 같음)		○ 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회(전문가)의견 등을 참조 - 현행 진료지침을 고시에 반영하여 중추성 사춘기조발증 환자에 대한 적정 진료가 이루어질 수

- 14 -

[421] 항악성종양제			
현 행		변 경(안)	사유
구 분	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	
	- 다 음 - 1) 자궁내막증 (생 략) 2) 중추성사춘기조발증 가) 투여대상 (1) <u>이차성징성숙도(Tanner stage) 2 이상</u> 이면서 골연령이 해당 역연령보다 증가되고, (2) GnRH(생식샘자극호르몬분비호르몬) 자극검사에서 황체형성호르몬(LH)이 기저치의 2-3배 증가되면서 최고 농도는 5 IU/L 이상인 경우 나) 투여기간	- 다 음 - 1) (현행과 같음) 2) 중추성사춘기조발증 가) 투여대상 (1) <u>이차성징성숙도(Tanner stage) 2 이상의 2차 성징이 역연령 여자 8세(7세 365일) 미만, 남자 9세(8세 365일) 미만에 발현되고,</u> (2) 골연령이 해당 역연령보다 증가되며, (현행과 같음) (3) GnRH(생식샘자극호르몬분비호르몬) 자극검사에서 황체형성호르몬(LH)이 기저치의 2-3배 증가되면서 최고 농도는 5 IU/L 이상인 경우 (현행과 같음) 나) (현행과 같음)	있도록 함.

- 15 -

[421] 항악성종양제			
현 행		변 경(안)	사유
구 분	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	
	(1) 투여시작: 역연령 여자 9세(8세 365일), 남자는 10세(9세 365일) 미만 (2) 투여종료: 역연령 여자 11세(11세 364일). 남자는 12세(12세 364일)까지 다) 성장호르몬제와의 병용 (1) 성장호르몬결핍증이 동반된 경우 GnRH(생식샘자극호르몬분비호르몬) agonis 주사제와 병용된 성장호르몬주사제도 인정함. (2) GnRH(생식샘자극호르몬분비호르몬) 주사제로 인한 성장속도 감소의 경우, 성장호르몬 주사제는 약값 전액을 환자가 부담함. 3) 자궁근종 (생 략) (이하 생략)	다) (현행과 같음) 3) (현행과 같음) (현행과 같음)	
※ 관련근거 1) Melmed: Williams Textbook of Endocrinology, 13th Ed. (2016)			

- 16 -

[421] 항악성종양제			
현 행		변 경(안)	사유
구 분	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	
2) Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 21th Ed. (2019) 3) The Korean Society of Pediatric Endocrinology Clinical Guidelines, 중추성 성조숙증 진료지침 2022 4) The Korean Society of Pediatric Endocrinology's Clinical Guidelines, 성조숙증 진료지침 2011 5) Lee PA, Neely EK,Fuqua J, Efficacy of Leuprolide Acetate 1-Month Depot for Central Precocious Puberty(CPP): Growth Outcomes During a Prospective, Longitudinal Study. Int J Pediatr Endocrinol. 2011;2011(1):7. Epub 2011 Jul 12. 6) Carel JC, Eugster EA, Rogol A, Ghizzoni L, Consensus statement on the use of gonadotropin-releasing hormone analogs in children. Pediatrics. 2009;123:e752-62. 7) Neeley EK, Wilson DM, Lee PA, Stene M, Hintz RL. Spontaneous serum gonadotropin concentrations in the evaluation of precocious puberty. J Pediatrics 1995;127:47-52.			